המועצה המדעית
SCIENTIFIC COUNCIL
ההסתדרות הרפואית בישראל
Israeli Medical Association
חינוך רפואי זו ההתמחות שלנו

המועצה המדעית ועדת הבחינות

בחינות שלב א'

רפואה פנימית

12.06.23

מס' השאלות בחלק זה :150

1. בן 80, עם אנדוקרדיטיס על רקע זיהום עם *Enterococcus* ובנוסף אי ספיקת כליות (קריאטינין 3 מ״ג/ד״ל). מה הטיפול במצב זה?

א. Ampicillin במינון גבוה עם Chloramphenicol
ב. Ampicillin במינון גבוה עם Ceftriaxone
ג. Linezolid
ד. Meropenem

2. בן 80, מתקבל עקב חום ממושך. באקו לב נמצאה וגטציה על המסתם האאורטלי, תרביות דם רבות עקרות, ו- IgG Phase I ל- *C. burnetii* מעל 1,000. מה הצעד הבא?

א. להתחיל טיפול רק אם הטיטר של ה- Phase II גבוה
ב. להתחיל ב- Doxycycline לשישה שבועות + Gentamicin לשבועיים
ג. לתת Gentamicin, Ciprofloxacin ו- Rifampicin למשך 3 חודשים
ד. לתת Doxycycline + Hydroxychloroquine למשך 18 חודשים

3. איזה תכשיר הוכח כמפחית תמותה?

א. Digoxin בחולים עם פרפור פרוזדורים ואי ספיקת לב עם מקטע פליטה ירוד
ב. Dabigatran בחולים עם פרפור פרוזדורים ומניעה שניונית
ג. Dapagliflozin בחולים עם סוכרת סוג 2 בסיכון קרדיווסקולרי גבוה
ד. Sacubutril-Valsartan בחולים עם אי ספיקת כליות דרגה 3 ומעלה

4. בן 85, מגיע לחדר המיון כשהוא מבולבל. לפני שבועיים אושפז בשל NSTEMI ושוחרר במצב טוב עם טיפול ב- Aspirin, Ticagrelor ו- Atorvastatin. בבדיקה כעת: בלבול ו- livedo reticularis. במעבדה: קריאטינין – 2 מ"ג/ד"ל (0.8 לפני שבועיים), BUN – 25 מ"ג/ד"ל. רמות C3 נמוכות. מה מומלץ לעשות כעת בהקשר לסיבה הסבירה ביותר שגרמה לאי ספיקת הכליות?

א. מתן סטרואידים
ב. מתן סטרואידים ו- Rituximab
ג. Plasmapheresis
ד. המשך מעקב

5. בן 42, פונה לחדר המיון בשל מדידת לחץ דם עם ערכים גבוהים. ברקע: מושתל כליה מזה 3 חודשים על רקע ADPKD ומטופל ב- Prednisone 10 mg, Everolimus, ו- Mycophenolate mofetil (MMF). בבדיקה: נראה חולה, מעט מבולבל, מתנשם, לחץ דם 200/100 ממ"כ, פורפורה על פני הגפיים. במעבדה: המוגלובין 6.5 גר'/ד"ל, טסיות 8,000 בממ"ק, קריאטינין 3 מ"ג/ד"ל. מה האטיולוגיה הסבירה ביותר למצבו?

א. הצרות בהשקה העורקית
ב. הרעלת MMF
ג. הרעלת Everolimus
ד. סינדרום קושינג יאטרוגני

6. בן 60, מאושפז בשל שלשול והמטומות מרובות בעור. ידוע על אי ספיקת הלב עם מקטע פליטה שמור, תסמונת נפרוטית, והפרעה כולסטטית. איזו בדיקה תוכיח את האבחנה הסבירה ביותר?

א. רמת ויטמין B3
ב. אספירצית שומן בטני
ג. רמת ויטמין C
ד. אלקטרופורזה של חלבוני הסרום

7. בת 80 לאחר כריתה שלמה של בלוטת התריס בשל ממאירות מפונה לחדר מיון בשל עייפות, חולשה ושקיעה במצב ההכרה בימים האחרונים. בבדיקה: שקועה עם תגובה לכאב אך לא לקול, חום רקטלי 33^0C. במעבדה: נתרן 127 מא"ק/ל, גלוקוז תקין ו- CPK 400 יח'/ל. מה הגישה הטיפולית המתאימה?

   א. עירוי של 50 מ"ל NaCl בריכוז 3%
   ב. Saline 0.9% מחומם תוך ורידי
   ג. מנה חד פעמית של Liothyronine בזונדה
   ד. Hydrocortisone תוך ורידי

8. מה נכון בהשוואה בין הטיפול ב- Pegylated-Interferon לעומת Nucleoside Analogue בחולה שחמת כבד על רקע זיהום כרוני ב- HBV?

   א. הטיפול ב- Pegylated-Interferon נסבל טוב יותר
   ב. משך הטיפול ב- Pegylated-Interferon ארוך יותר
   ג. Nucleoside Analogue יעיל יותר כשהעומס הנגיפי גבוה
   ד. יש יותר antiviral resistance ל- Pegylated-Interferon

9. בן 60, סובל משחמת כבד לא מפוצה (Decompensated cirrhosis) על רקע Chronic hepatitis C. בעבר טופל ב- Ribavirin וגם ב- Direct antivirals (DAA). מה העיקרון הנכון לטיפול ב- DAA כעת במקרה זה?

   א. קיימת כעת קונטרא-אינדיקציה ל- DAA עד לאחר השתלת כבד
   ב. אין יתרון לתת Ribavirin יחד עם DAA
   ג. יש להימנע מלטפל שוב ב- DAA
   ד. יש להימנע ממתן DAA המכילים Protease inhibitors

10. למי מיועד טיפול ב- Chimeric antigen receptor T cells (CAR-T)?

א. חולים עם Peripheral T cell lymphoma בהישנות או רפרקטורית
ב. חולים עם Anaplastic large cell lymphoma בהישנות או רפרקטורית
ג. חולים עם Diffuse large B cell lymphoma בהישנות או רפרקטורית
ד. חולים עם Mantle cell lymphoma בקו ראשון

11. בת 68, עם COPD ותסמינים משמעותיים, והיא משתמשת לסירוגין בחמצן, לפי הצורך, מאושפזת בשל התלקחות ה- COPD, וריווי החמצן 85% באוויר החדר. מה מומלץ לגבי טיפול בחמצן בחולה זו?

א. יש לתת חמצן כדי שהסטורציה תישמר מעל 90%
ב. יש לתת חמצן במינון עד 2 ליטר לדקה
ג. אין מקום לטיפול בחמצן בחולה זו
ד. יש לטפל בחמצן רק בשעות הלילה

12. בן 30, התקבל בשל פלפיטציות, כשברקע Hypertrophic cardiomyopathy. על מה יש להמליץ כעת?

א. השתלת ICD
ב. צנתור כלילי
ג. מבחן מאמץ
ד. MRI לב

13. בן 60 עם STEMI, יציב המודינמית ובמוניטור הופעה של פעימות מוקדמות ממקור חדרי. איזו תרופה מומלצת כטיפול מונע להפרעות הקצב החדריות?

א. β-blocker
ב. Abciximab
ג. Verapamil
ד. Lidocaine

14. איזה מצב קשור לזיהום ב- BK virus?

א. אנצפליטיס בחולים עם דיכוי חיסוני קשה
ב. פנציטופניה משמעותית במושתלי מוח עצם
ג. סטריקטורות בדרכי השתן במושתלי כליה
ד. דחיית שתל במושתלי כבד

15. מה הטיפול הנכון בדלקת בדרכי השתן?

א. בגברים משך הטיפול המומלץ הוא לפחות 7 ימים
ב. בנשים עם פיאלונפריטיס מומלץ טיפול לפחות ל- 14 ימים
ג. בגברים עם ציסטיטיס פשוטה מומלץ בטא-לקטם ל- 3 ימים
ד. בנשים עם ציסטיטיס פשוטה מומלץ בטא-לקטם ל- 3 ימים

16. בן 27, מעורפל הכרה עם חום $38.7^{o}C$, לחץ דם 160/90 ממ"כ, דופק 120 בדקה, מזיע ורפלקסים ערים. באנמנזה שתיית Methanol, שימוש ב- Ketamine, וטיפול ב- Dipyrone, Tramadol, Escitalopram ו- Risperidone. מה מביניהם מסביר את התמונה הקלינית בסבירות <u>הגבוהה ביותר</u>?

א. Escitalopram
ב. Ketamine
ג. Risperidone
ד. Methanol

17. בן 40, מופנה בשל אי ספיקת כליות כרונית ומתלונן על תחושת שריפה אפיזודית בכפות הידיים והרגליים, כשבשתן פרוטאינוריה 1.5 ג'. בבדיקתו: קולות לב סדירים עם קול שני מודגש, וממצאים בעור (**תמונה 1**). מה הטיפול המומלץ?

א. Plasma exchange
ב. Enzyme replacement therapy
ג. Chelation therapy
ד. Bone marrow transplantation

18. כמה מחולי סוכרת מפתחים Diabetic nephropathy?

א. כ- 25%
ב. כ- 40%
ג. כ- 75%
ד. כ- 90%

19. בת 75, מתלוננת על נוקשות וכאב בעורף, בחגורת הכתפיים ובירכיים מזה כשבועיים, ללא כאב ראש וללא הפרעות בראיה. במעבדה אנמיה קלה ושקיעת דם 100 בשעה ראשונה. מה הטיפול המקובל בקו ראשון?

א. Prednisone 10-20 מ״ג
ב. Prednisone במינון 1 מ״ג לק״ג
ג. Tocilizumab במינון 8 מ״ג לק״ג
ד. Ibuprofen במינון 800 מ״ג, שלוש פעמים ביום

20. מה <u>היעיל ביותר</u> במניעת זיהומים הקשורים לצנתרים ורידיים במאושפזים?

א. להחליף עירויים פריפריים כל 24 שעות
ב. להימנע ככל הניתן משימוש בצנתרים ג׳וגולריים ולהעדיף צנתרים פמורליים
ג. לתת אנטיביוטיקה מניעתית עם β-Lactam לפני החדרת כל צנתר מרכזי
ד. רחצה יומית של חולים בטיפול נמרץ/מוגבר ב- Chlorhexidine

21. בן 30 פונה לחדר המיון בשל חום מלווה ברעידות וירידה במשקל בשבוע שקדם לקבלתו. בבדיקה: חום 38^0C, רעד ניכר בידיים ורגישות במישוש בלוטת התריס. במעבדה: FT4 40 (נורמה 10-20), ו- TSH לא מדיד. במיפוי לא מודגמת קליטה בבלוטת התריס. מה האבחנה הסבירה ביותר?

א. Graves disease
ב. Toxic adenoma
ג. Pituitary adenoma
ד. Thyroiditis

22. איזו תרופה לא גורמת לשינוים שומניים (Steatosis) בכבד?

א. Nitrofurantoin
ב. Methotrexate
ג. Tamoxifen
ד. Amiodarone

23. בחולים עם Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, מה ישפר את הפיברוזיס ללא קשר להורדה במשקל?

א. הימנעות מצריכת קפה
ב. פעילות גופנית אירובית (20 דקות, 2-3 פעמים בשבוע)
ג. דיאטה ים-תיכונית
ד. תוספי ויטמין E

24. מה מהווה טיפול מקובל ב- Cold agglutinin disease?

א. כריתת טחול
ב. סטרואידים תוך ורידית
ג. Rituximab
ד. Eculizumab

25. בן 66, עם COPD, מטופל מזה כשנה וחצי במשאף משולב של LABA+LAMA. לפני כ- 4 חודשים, בעקבות התלקחות, טופל ב- Prednisone ולא אושפז. כעת, אושפז עם התלקחות COPD קשה. ה- FEV1 53% מהצפוי ובספירת הדם 11,000 לויקוציטים בממ"ק עם 250 אאוזינופילים. מה יומלץ כטיפול המשכי בשחרורו?

א. טיפול קבוע ב- Prednisone
ב. שינוי המשאף למשלב של ICS+LABA
ג. שינוי המשאף למשלב של ICS+LABA+LAMA
ד. הוספת טיפול בחמצן במשך מרבית שעות היממה

26. בן 55, התקבל לאשפוז עם STEMI בקיר תחתון ו- CAVB. בבדיקה: לחץ דם 140/60 ממ"כ, דופק 40 לדקה, ריווי חמצן 96%, ללא חום. מה הסיבה השכיחה ביותר ל- CAVB במצב זה?

א. הטיפול ב- Ticagrelor
ב. עלית לחץ בלב הימני
ג. פגיעה איסכמית במערכת ההולכה
ד. שחרור של אדנוזין

27. בן 40, עם כאב חזה לא טיפוסי לתעוקה. ברקע Hypertrophic cardiomyopathy, ללא סוכרת או יתר לחץ דם. בבדיקה: לחץ הדם 130/80 ממ"כ, דופק 70 בדקה. תרשים האק"ג **בתמונה 2**. מה יכלול הטיפול?

א. Low dose Aspirin
ב. Reassurance
ג. Isosorbide Dinitrate
ד. Factor Xa inhibitor

28. בן 60, עם מחלת חום וכאבי ראש כשבוע. בבדיקה סימני conjunctivitis ובמעבדה אי ספיקת כליות חדה ועליה בבילירובין ישיר. מה הטיפול האמפירי המומלץ?

א. Vancomycin
ב. Ceftriaxone
ג. Levofloxacin
ד. Metronidazole

29. בן 22, מטופל באופן קבוע ב- Methylphenidate, מופנה לחדר המיון כשעתיים לאחר בליעת 18 גרם Acetaminophen (Paracetamol). במעבדה: ספירת דם תקינה, AST 620 יח׳/ל ו- ALT 700 יח׳/ל, קריאטינין תקין. רמת Acetaminophen 120 מק״ג/מ״ל. מה ניתן להניח לגבי מצבו?

א. תיזמון בדיקת רמת ה- Paracetamol, שולל אפשרות לפגיעה טוקסית
ב. רמת אנזימי הכבד מרמזת על פתולוגיה אחרת מפגיעת ה- Paracetamol
ג. יש להתחיל טיפול בקו ראשון ב- Saline תוך ורידי ובפחם פעיל פומי
ד. הרעילות הכבדית גבוהה יותר בגלל הטיפול הקבוע ב- Methylphenidate

30. באיזה חולה עם היפונתרמיה, הסובל מאחד המצבים הבאים, צפויות רמות נמוכות של Vasopressin (AVP)?

א. Low solute intake
ב. Congestive heart failure
ג. Nephrotic syndrome
ד. Primary adrenal insufficiency

31. מה נכון לגבי תיקון היפונתרמיה?

א. תוספת אשלגן לנוזלים הניתנים לחולה עשויה לתרום לעליה בריכוז הנתרן
ב. בהיפונתרמיה אקוטית מותר להעלות את ריכוז הנתרן עד 12 מא"ק ליממה
ג. אין מקום לטיפול ב- DDAVP בחולים עם היפונתרמיה
ד. ניתן לתקן היפונתרמיה של beer potomania מהר יותר מאטיולוגיות אחרות

32. בן 33, מופנה בעקבות בדיקת CT בטן שבוצעה בשל כאבי בטן **בתמונה 3**. בנוסף, נוגדנים חיוביים ל- anti-β2 glycoprotein, anti-cardiolipin ו- Lupus anticoagulant חיובי. מה עוד יחשיד שלמטופל יש זאבת ולא "רק" תסמונת APLA?

א. תלונות/אבחנה של מיגרנה
ב. תלונות/ממצאים של כוריאה (Chorea)
ג. לויקופניה עם לימפופניה
ד. תרומבוציטופניה

33. מה נכון לגבי הטיפול במחלת Graves?

א. בטיפול ב- PTU יש שכיחות גבוהה של פגיעה כבדית
ב. טיפול ביוד נועד להרוס את הבלוטה ולהשרות תת תריסיות
ג. יש לנטר את יעילות הטיפול מהתחלתו ע"י מדידת TSH
ד. שיתוק ה- recurrent laryngeal שכיח לאחר כריתת הבלוטה

34. מה <u>לא</u> אופייני כממצא בבדיקה, המופיע **בתמונה 4**, של חולים עם שחמת כבד?

א.
ב.
ג.
ד.

35. כיצד יש לטפל בחולה שחמת עם דימום חד מדליות?

א. לשמר המוגלובין מעל 10 גר׳/ד״ל
ב. לתת PCC
ג. לתת אנטיביוטיקה מניעתית
ד. להימנע ממתן תרופות וזוקונסטריקטיביות

36. מה מהבאים מאפיין Myelodysplastic syndrome (MDS)?

א. טחול מוגדל קיים במרבית החולים
ב. בבדיקת מח העצם סביר למצוא תמונה היפרצלולרית
ג. נויטרופניה חמורה מהווה את המופע הקליני הנפוץ ביותר
ד. הפרעות ציטוגנטיות מופיעות בכעשרה אחוזים מחולי MDS

37. לאיזה מצב/מחלה יכולים להתאים תפקודי הריאות הבאים (הכל בערכים מהצפוי):
FVC 60%, FEV1 75%, TLC 60%, FRC 60%, DLCO 60%?

א. Idiopathic Pulmonary Fibrosis
ב. Myasthenia Gravis
ג. Morbid Obesity
ד. Emphysema

38. למי מהמטופלים הבאים הסובלים מאי ספיקת לב ומטופלים ב- Furosemide תוך ורידית באשפוז, מתאים טיפול ב- Vericiguat?

		טיפול כעת
א.	בן 70 עם HFrEF	MRA, SGLT2i, ACEi, Carvedilol
ב.	בת 66 עם HFpEF	MRA, SGLT2i, ACEi
ג.	בן 60 לפני ניתוח אלקטיבי	Sacubitril-Valsartan
ד.	בת 32 עם Peripartum Cardiomyopathy	

39. בן 33 עם קוצר נשימה ואבחנה של פרינגיטיס ויראלי. בשל טאכיקרדיה נלקחה בדיקת טרופונין עם תוצאה חיובית. באקו לב EF 40%, ללא נוזל פריקרדיאלי. איזו תרופה יכולה לעזור למצבו?

א. Oseltamivir
ב. Tocilizumab
ג. Prednisone
ד. Furosemide

40. מה נכון לגבי תוצאות ניקור המפרק במצב של Septic arthritis, שאינו קשור לזיהום שמקורו ב- *N. gonorrhea*?

א. צביעת גרם תהיה חיובית ב- 90% מהמקרים
ב. התרבית תהיה חיובית ביותר מ- 60% מהמקרים
ג. ספירת תאים אופיינית: WBC 30-50,000/μL
ד. רמות LDH בנוזל בדרך כלל נמוכות

41. בת 85, התקבלה עקב חום וכאבי גב עזים. בתרבית דם *E. coli* ובבדיקת CT יש אוסטיאומיאליטיס ב- L2-3. מה הגישה הנכונה לטיפול?

א. יש צורך בדרך כלל בהתערבות כירורגית כדי להשתלט על הזיהום
ב. יש צורך בטיפול בשתי אנטיביוטיקות כולל אמינוגליקוזיד
ג. במרבית החולים יספיק טיפול אנטיביוטי למשך 6 שבועות
ד. יש לתת את כל הטיפול תוך-ורידית

42. מה נכון לגבי Transgender man, Female to Male?

א. רובם עוברים ניתוח להתאמה מגדרית
ב. נמצאים בסיכון נמוך לשימוש בסמים לעומת האוכלוסייה הכללית
ג. יש לבדוק צורך בבדיקות מעקב של PAP smear תקופתיות
ד. אם מקבלים טיפול הורמונלי אין צורך באמצעי מניעה

43. מה עלול בסבירות הגבוהה ביותר לגרום להיפרנתרמיה?

א. Hypocalcemia
ב. Hyperkalemia
ג. Osmotic diarrhea
ד. Secretory diarrhea

44. איזה תופעה עלולה להיגרם ע״י היפוקלמיה כרונית?

א. תת לחץ דם
ב. חמצת מטבולית
ג. פוליאוריה
ד. שלשול

45. בת 60, מתלוננת על נימול בידיים וברגליים. ברקע Seropositive Rheumatoid Arthritis מגיל 25 עם כישלון קווי טיפול מרובים. כעת מטופלת ב- Prednisone 5 מ״ג בלבד בשל מפרקים רבים תפוחים ורגישים. מה הבדיקה הדחופה הראשונה שיש לבצע?

א. EMG
ב. CT חזה
ג. הדמיית עמ״ש צוואר
ד. בדיקת משלים בדם

46. בן 50, מתאשפז בשל בצקות בגפיים התחתונות ועלייה במשקל. בבדיקה: השמנה מרכזית ודלדול שרירים פריפרי עם יתר לחץ דם של 160/90 ממ"כ. במעבדה: אשלגן 2.9 מא"ק/ל ובסיסת מטבולית. במבחן דיכוי דקסמתזון במינון נמוך אין דיכוי, ואיסוף שתן לקורטיזול חופשי מדגים ערכים פי 5 מהנורמה. במבחן דיכוי דקסמתזון במינון גבוה יש דיכוי, ובבדיקת ACTH ערכים פי 3 מהנורמה. מה הצעד האבחנתי הבא?

א. בדיקת Cortisol בחצות ברוק לאימות האבחנה
ב. CT כלל גופי או PET לאיתור מקור אקטופי
ג. MRI של ההיפופיזה לשלילת גידול מפריש
ד. CT של הבטן לאיתור גידול אדרנלי מפריש

47. מה התווית הנגד (קונטרא-אינדיקציה) למתן סטרואידים ב- Severe Alcoholic hepatitis?

א. דימום בלתי נשלט מדליות
ב. מיימת
ג. היפונתרמיה
ד. INR גבוה מעל 2

48. בן 25, מתלונן על אירועי קושי בבליעת מוצקים, ללא ירידה במשקל. ברקע אסתמה. בגסטרוסקופיה נמצא מראה של טבעות בושט ללא היצרות, מעבר תקין לקיבה, קיבה ותריסריון תקינים. בביופסיות מהושט - הסננה אאוזינופילית של האפיתל (40 אאוזינופילים ל- High power field). אין אאוזינופיליה בספירת הדם. מה הטיפול המיטבי?

א. דיאטה מכוונת ע"י תבחיני עור לאלרגנים
ב. Prednisone במינון 1 מ"ג לק"ג
ג. מתן PPI ו- swallowed topical steroids
ד. טפול אנטי חרדתי

49. בן 50 מתלונן על חולשה ועייפות. במעבדה: המוגלובין 13 גר״/ד״ל, לויקוציטים 8,500 בממ״ק, טסיות תקינות, בדיקות הכימיה תקינות, סטורציית טרנספרין 10%, במעבדה שקיעת דם אינה מוחשת. מה יש לעשות כעת?

א. אלקטרופורזה של המוגלובין
ב. אנדוסקופיה של מערכת עיכול
ג. US בטן
ד. מעקב

50. בת 52, הסובלת מאסתמה ומטופלת בקביעות במשאף משולב של ICS+LABA במינון גבוה, מגיעה לחדר מיון ומתארת קוצר נשימה קשה שהחל סביב מאמץ בזמן סופת אבק. בבדיקתה חום 36.4^0C, ריווי חמצן 96% באוויר החדר, 24 נשימות לדקה, וצפצופים אקספירטוריים. טופלה באינהלציות של ביטא-אגוניסטים ואנטיכולינרגיים עם שיפור קל בלבד. במה עוד ניתן לטפל, מעבר לסטרואידים סיסטמיים, כדי להביא לשיפור במצבה?

א. מגנזיום
ב. חמצן
ג. Amoxicillin
ד. טיפול חד פעמי בנוגדי IL-5

51. איזו ממצא בבדיקה גופנית אופייני ל- MVP בניגוד ל- MR פונקציונלי?

א. החלשות האוושה כשהחולה על צד שמאל
ב. התגברות האוושה ברכינה קדימה
ג. התגברות האוושה בזמן ולסלבה
ד. החלשות האוושה כשהחולה בעמידה

52. בן 43 עם פלפיטציות וסחרחורות, ללא תעוקת חזה. ללא מחלות רקע או טיפול תרופתי קבוע. בבדיקה: בהכרה, ולחץ הדם הסיסטולי 100 ממ"כ. תרשים סטריפ מהאק"ג **בתמונה 5**. איזה מהבאים הוא הסיבה הסבירה למצבו?

א. Hypokalemia
ב. Hyperkalemia
ג. Hypophosphatemia
ד. Hyperphosphatemia

53. בזמן התפרצות של *Candida auris*, מתקבלת הודעה על צמיחת פטריות בתרביות דם בחולה מונשם במצב המודינמי יציב וללא נויטרופניה. מה הטיפול האמפירי המומלץ?

א. Voriconazole
ב. Liposomal Amphotericin
ג. Posaconazole
ד. Caspofungin

54. מהו גורם הסיכון העיקרי ל- Emphysematous pyelonephritis בחולים עם זיהומים בדרכי השתן?

א. נויטרופניה ממושכת
ב. מחלת אבני כליה
ג. קטטר קבוע בדרכי השתן
ד. סוכרת

55. בת 56, עם שלשול, חולשת שרירים, Alopecia ועליה ב- CPK מזה כשבוע. הרעלה של איזו תרופה עלולה לגרום לכך?

א. Prednisone
ב. Colchicine
ג. Adalimumab
ד. Atorvastatin

56. מה האטיולוגיה הסבירה ביותר להיפוקלמיה בחולה הסובל מלחץ דם גבוה וערכי אלדוסטרון נמוכים?

א. Liddle's syndrome
ב. Renal artery stenosis
ג. Renin secreting tumor
ד. Malignant Hypertension

57. מה האטיולוגיה הסבירה ביותר להיפרקלצמיה של חולה עם תוצאות הבדיקות הבאות?

	Plasma (mg/dL)	Urine (mg/dL)
Ca	12	8
P	3.5	
Creatinine	1	80

א. Primary hyperparathyroidism
ב. Vitamin D intoxication
ג. Familial hypocalciuric hypercalcemia
ד. Bone metastasis

58. בן 70, מועבר למחלקה פנימית מאא"ג בשל קוצר נשימה וממצאי DVT. באא"ג, אושפז בשל כונדריטיס באוזן מלווה בחום סיסטמי, אנמיה מקרוציטית, לויקופניה קלה ותרומבוציטופניה, כשמסתבר שמדובר באירועים חוזרים המגיבים לסטרואידים במינון גבוה אך נשנים בהפחתת המינון. במעבדה: ANA, ANCA, RF, משלים ונוגדני APLA שליליים. איזו בדיקה תסביר את התמונה הקלינית?

א. α1 anti-tripsin
ב. HLA B27
ג. Anti-ds DNA
ד. UBA1 gene mutation

59. בן 22 פונה בשל חולשה. בבדיקה: לחץ דם 100/60 ממ"כ, והיפרפיגמנטציה בכפות הידיים וברירות. במעבדה: נתרן 125 מא"ק/ל, אוסמולריות בשתן 400, וריכוז נתרן בשתן 40. איזה פרט באנמנזה של החולה יתאים ביותר לתמונה המתוארת?

א. הוא יהודי ממוצא איראני ולאחותו אירועים חוזרים של פטרת ברירות
ב. מטופל ב- Levothyroxine מזה שנתיים לאחר שחלה ב- Hashimoto
ג. טופל לאחרונה במעכבי tyrosine kinase עקב מלנומה גרורתית
ד. טופל עד לאחרונה בסטרואידים במינון גבוה והפסיק ללא tapering

60. בן 60, עם תלונת של אי נוחות ברום הבטן. בגסטרוסקופיה: בושט יש לשונית ורדרדה באורך כ- 4 ס"מ פרוקסימלית למעבר ושט-קיבה, לא נראו סימני דלקת בושט, רירית הקיבה והתריסריון תקינות. בביופסיה מהלשונית - מטפלזיה של תאים עמודיים, עם אזור של High grade dysplasia. מה יש להמליץ לחולה?

א. אבלציה אנדוסקופית של הרירית
ב. PPI ומעקב אנדוסקופי וביופסיות חוזרות
ג. כריתת ושט
ד. מעקב בלבד ללא צורך בטיפול

61. בת 21, ללא מחלות רקע. מתלוננת מזה כשנה על שלשול מימי כ- 5-6 פעמים ביום. במעבדה: המוגלובין 8 גר'/ד"ל, MCV 65, רמת ברזל 30, פריטין 3. בדיקת CRP וקלפרוטקטין בצואה תקינות, רמת IgA תקינה, רמת Anti-tissue transglutmainase IgA פי 10 מהנורמה. איך יש להתקדם?

א. בדיקות HLADQ2 ו- HLADQ8
ב. בדיקת Deamidated anti-gliadin IgG
ג. גסטרוסקופיה וביופסיות מהתריסריון
ד. מעקב ודיאטה נטולת גלוטן

62. בת 43, שסיימה טיפול ב- Rafapen בשל דלקת בלוע, פונה בשל חולשה קיצונית. בבדיקתה, חיוורון וצהבת. במעבדה המוגלובין 8 גר'/ד"ל, MCV 90, רטיקולוציטים של 150,000 בממ"ק וקומבס חיובי. מה הצעד הבא בניהול המקרה?

א. Rituximab
ב. Observation
ג. Steroids
ד. Plasmapheresis

63. בן 44, מתגורר במושב חקלאי, מעשן כחצי קופסה ליום מזה 25 שנה. בשבועות האחרונים סובל מקוצר נשימה, שיעול יבש, חולשה, עייפות ומציין ירידה במשקל. בתפקודי ריאות ישנה תמונה רסטריקטיבית עם חסימה קלה וירידה קלה בדיפוזיה. CT חזה **בתמונה 6**. מה האבחנה הסבירה?

א. Hypersensitivity Pneumonitis
ב. Asbestosis
ג. Bronchiolitis Obliterans
ד. Non-TB Bronchiectasis

64. בן 56, מתלונן על פלפיטציות. תרשים האק"ג **בתמונה 7**. מה הטיפול היעיל ביותר במצב זה?

א. Adenosine
ב. β-blockers
ג. Ablation
ד. Propafenone

65. לאיזה מחולל קשורה אבחנה של Hairy Leukoplakia בחולה HIV?

א. Epstein-Bar Virus
ב. Cytomegalovirus
ג. Varicella
ד. Herpes Simplex Virus

66. מה הטיפול המתאים לארתריטיס ספטית ללא סיבוכים סיסטמיים, כשבתרבית מדיקור הנוזל *S. aureus* רגיש ל- Methicillin?

א. Oxacillin בהזרקה לתוך המפרק
ב. IV Oxacillin למשך שישה שבועות
ג. PO Rifampin + IV Oxacillin למשך ארבעה שבועות
ד. IV Oxacillin למשך שבועיים ואחר כך טיפול פומי לשבועיים

67. מה נכון לגבי בדיקת D-Dimer בקשר ל- VTE?

א. Specificity ו- Positive predictive value גבוהים
ב. Specificity ו- Negative predictive value גבוהים
ג. Sensitivity גבוהה ו- Negative predictive value נמוך
ד. Sensitivity ו- Negative predictive value גבוהים

68. באיזה מצב של היפרקלצמיה, יוכל טיפול בסטרואידים לתקן את ערכי הסידן?

א. חולה עם Hodgkin's disease
ב. חולה הסובל מהרעלת ויטמין D יאטרוגנית
ג. חולה המטופל ב- Lithium
ד. חולה המטופל ע"י TPN

69. איזה שילוב אופייני להפרעת חומצה-בסיס ומצב/מחלה?

	מצב/מחלה	הפרעת חומצה-בסיס
א.	ספסיס גרם שלילי	חמצת נשימתית
ב.	הריון	בססת מטבולית
ג.	אי ספיקת כבד	בססת נשימתית
ד.	הרעלת סליצילטים	חמצת נשימתית

70. בת 75, מתעניינת בטיפול ביולוגי ל- Rheumatoid Arthritis עמיד לטיפול בכל התרופות שקיבלה. ברקע מחלת לב איסכמית, סוכרת, יתר לחץ דם, גאוט, השמנת יתר ו- DVT לפני כ- 3 חודשים. מאיזה טיפול כדאי להימנע?

א. Adalimumab
ב. Tocilizumab
ג. Tofacitinib
ד. Abatacept

71. מה עיקרון הטיפול בסוכרת <u>בחולה המאושפז</u>?

א. במרבית המטופלים יש לשאוף לערכי glucose של 80-110 מ"ג/ד"ל
ב. יש להעדיף מתן אינסולין בשיטת sliding scale על פני basal bolus
ג. יש לשלב GLP1 agonist עם אינסולין בסוכרת מטיפוס 1
ד. בחולים קריטיים יש לשאוף לערכי glucose של 140-180 מ"ג/ד"ל

72. בן 35 עם קוליטיס כיבית מזה 15 שנים, ידוע על פאנקוליטיס, מקבל טיפול ב-Infliximab מזה 3 שנים. מרגיש טוב, ללא שלשול וללא כאבי בטן. בקולונוסקופיה מהאנוס עד הקולון הרוחבי ללא סימני דלקת, בקולון הרוחבי היצרות ללא אפשרות למעבר של הקולונוסקופ. מה מומלץ?

א. טיפול ניתוחי
ב. הרחבה אנדוסקופית של ההיצרות
ג. החלפת הטיפול הביולוגי
ד. העלאת מינון ה- Infliximab

73. בת 25, מתלוננת מזה שנה על שלשול, כאבי בטן וירידה במשקל. במעבדה: אנמיה של חסר ברזל, CRP מוגבר, וקלפרוטקטין תקין. בקולונוסקופיה מודגם מעי גס עם רירית תקינה, באילאום הסופי מספר כיבים קטנים וביניהם רירית תקינה. לאיזו בדיקה יש את ה- Yield <u>הגבוה ביותר</u> לאבחון היקף המעורבות של מחלת המעי הדק?

א. Endoscopic capsule
ב. CT enterography
ג. MR enterography
ד. Abdominal CTA

74. מה הגורם <u>הסביר ביותר</u> להפרעת הקצב המופיעה בתרשים האק"ג **בתמונה 8**?

א. Long QT syndrome
ב. WPW syndrome
ג. AVNRT
ד. Hypomagnesemia

75. בת 36, מתקבלת למחלקה בשל גרד עז ופריחה. בקבלתה יציבה המודינמית ונשימתית, בבדיקה: גודש בורידי הצוואר, יתר הבדיקה הגופנית תקינה. צילום החזה **בתמונה 9**, וב- CT קשריות מעל עצם הבריח (supraclavicular) משמאל. בביופסיה מהממצא תאים חיוביים ל- CD30 CD15 ושליליים ל- CD19 CD20. מה הטיפול המתאים במצבה?

א. R-CHOP
ב. קרינה למדיאסטינום
ג. ABVD וקרינה
ד. Bendamustine ו- Rituximab

76. מה האינדיקציה העיקרית לביצוע Endobronchial Ultrasound Guided Transbronchial Needle Aspiration (EBUS-TBNA)?

א. הגדלת חד צדדית של בלוטות לימפה מדיאסטינליות
ב. זיהום ממושך במדוכא חיסון שאינו מגיב לטיפול
ג. סקירת הריאות במחלות פרנכימטיות וביופסיה
ד. חשד למחלת ריאות אינטרסטיציאלית

77. לאיזה טיפול <u>אין</u> אינדיקציה בחולים עם איסכמיה שקטה בנוכחות מחלה כלילית קודמת?

א. β-blockers
ב. Aspirin
ג. Statins
ד. Nitrates

78. מה מהווה גורם סיכון ל- VTE?

א. רמת LDL נמוכה
ב. רמת Triglycerides פי 2 מהנורמה
ג. רמת LPa (ליפופרוטאין a) גבוהה
ד. רמת Erythropoietin נמוכה

79. מה עיקרון הטיפול בבן 30 עם פרינגיטיס על רקע Group A *Streptococcus*?

א. טיפול סימפטומטי ללא טיפול אנטיביוטי
ב. טיפול אנטיביוטי קצר (3-5 ימים) למניעת סיבוך של Endocarditis
ג. טיפול אנטיביוטי של 10 ימים למניעת Acute Rheumatic Fever
ד. טיפול ב- Penicillin למשך 10 ימים למניעת Fasciitis

80. מה נכון לגבי שיטת אבחון בחשד לזיהום במערכת הנשימה?

א. תרביות דם חיוביות בכ- 50% בדלקת ריאות פנאומוקוקלית
ב. רגישות תרבית כיח עשויה להיות נמוכה גם במקרה בקטרמיה
ג. אנטיגן ל- *Legionella* בשתן <u>לא</u> יעיל בזיהוי בזיהום ממקור בקהילה
ד. בדיקות סרולוגיות יכולות לתת תשובה מיידית לזהות הפתוגן

81. בת 31, מובאת לחדר המיון מעורפלת הכרה עם לחץ דם 95/50 ממ"כ, דופק 45 לדקה, ללא חום, אישונים צרים ופריסטלטיקה ירודה. מה יש לעשות כעת?

א. IV Noradrenaline
ב. IV Naloxone
ג. IV NaCl 0.9% 1,000 mL
ד. IV Atropine 1 mg

82. איזו אטיולוגיה עלולה לגרום להיפוקלמיה ובססת מטבולית ללא יתר לחץ דם?

א. Pseudo hyperaldosteronism type II
ב. IV Penicillin treatment
ג. Liddle's syndrome
ד. IV Acetazolamide treatment

83. בן 62, מושתל כליה על רקע נפרופתיה סוכרתית. מאושפז בשל פצע סוכרתי לא מזוהם ש"מסרב" להתרפא כבר למעלה מחודש. הפסקה של איזו תרופה תסייע לריפוי?

א. Cyclosporine
ב. Tacrolimus
ג. Everolimus
ד. Mycophenolate mofetil

84. בן 52, מופנה לבירור בשל עליה באנזימי כבד הפטו-צלולריים (פי 3 מהנורמה), יציב בחצי השנה האחרונה, ללא תסמינים נלווים או פגיעה סינטטית בתפקוד הכבד. בירור סרולוגי, ויראלי ואוטואימוני – שלילי. בעקבות ממצא של לימפאדנופתיה בשערי הריאות נלקחת ביופסיה המוצגת **בתמונה 10**. צביעה ל- Ziel Neelsen שלילית. מה יש להציע לחולה כעת?

א. מעקב בלבד
ב. Prednisone 10-20 מ"ג
ג. Prednisone 40 מ"ג
ד. Prednisone 1 מ"ג לק"ג

85. בת 40 ללא רקע רפואי מפונה בשל אובדן הכרה. בבדיקה: גלוקוז 40 מ"ג/ד"ל. היא מתעוררת, מתמצאת באופן מלא, שוללת שימוש באינסולין או תרופות אחרות ומציינת ירידה במשקל של 5 ק"ג בחצי השנה האחרונה ללא שינוי בתזונה. כעת בצום מופיעה היפוגליקמיה (30 מ"ג/ד"ל) ובדיקות לאינסולין ול- c peptide בטווח הנורמה. מה ניתן להניח בסבירות גבוהה?

א. אפשר לשלול שימוש בסולפונילאוריאה
ב. צפויה תגובה טובה לעירוי גלוקוז אבל לא לגלוקגון
ג. ריכוז גופי קטו צפוי להיות נמוך
ד. קרוב לוודאי שנמצא אינסולין שהיא מזריקה לעצמה

86. בן 65, עם מלנומה גרורתית וטיפול ב- Nivolumab, מאושפז בשל שלשול (12 יציאות ביום). בקולונוסקופיה מודגמת קוליטיס קשה, ולכן מטופל בסטרואידים אך ללא שיפור במצבו. מה מהבאים הוא טיפול אפשרי במצבו?

א. Cyclosporine
ב. Anti-TNF
ג. Methotrexate
ד. Azathioprine

87. מה הדרך הטובה והנפוצה ביותר לאשש אבחנה של IgA vasculitis?

א. צביעת PAS של ביופסיית כליה
ב. אימונופלורסנציה של ביופסיית עור
ג. צביעת H&E של ביופסיה מהמעי הדק
ד. צביעת גימזה של ביופסיית מח עצם

88. בת 43, מתלוננת לאחרונה על כאב ראש, חולשה, ירידה בתפקוד ועייפות, והיום על כאב בטן עז. מדדים חיוניים תקינים, הבטן רגישה במישוש ואין הגדלת איברים.
במעבדה: כימיה וספירת דם תקינה למעט אריתרוציטוזיס. כימיה תקינה.
באולטראסאונד תרומבוס בוריד ההפטי. איזו בדיקה תקדם את הבירור בשלב זה?

א. בדיקה לחלבון S
ב. β2 microglobulin
ג. הומוציסטאין
ד. JAK2 Exon 12

89. בן 76, מאובחן כסובל מ- Granulomatosis with polyangiitis (GPA). בימים האחרונים סובל מחולשה וחום, ומאתמול המופטיזיס. בהגיעו למיון נראה דימום משמעותי של כוס דם. בצילום חזה עכירות ותסנינים במרבית הריאה הימנית. מה הטיפול המתאים?

	טיפול ראשוני	טיפול לאחר הטיפול הראשוני
א.	השכבה על צד ימין	אמבוליזציה באנגיוגרפיה
ב.	השכבה על צד שמאל	כריתת האזור המדמם
ג.	השכבה על צד ימין	כריתת האזור המדמם
ד.	השכבה על צד שמאל	ברונכוסקופיה ומתן Cyclophosphamide

90. למי מהנבדקים הבאים שביצעו בדיקת "דופלר קרוטידים" כבדיקת סקר, יש את הסיכוי <u>הנמוך ביותר</u> לפתח אירוע מוחי?

א. בן 75, עם הצרות של 80% של הקרוטיד השמאלי
ב. בת 80, עם הצרות של 85% של הקרוטיד הימני
ג. בן 75, עם הצרות של 85% של הקרוטיד השמאלי
ד. בת 80, עם הצרות של 95% של הקרוטיד הימני

91. מה יכוון ביותר לאבחנה של יתר לחץ דם ריאתי?

א. ממצא באקוקרדיוגרפיה של חדר ימני מורחב או היפרטרופי
ב. ממצא באקוקרדיוגרפיה של לחץ דם ריאתי 33 ממ"כ
ג. יחס גל E/E' גבוה בבדיקת אקוקרדיוגרפיה
ד. DLCO גבוה במסגרת תפקודי ריאות

92. מה הטיפול המתאים לבן 30, יומיים לאחר נשיכת חתול, כשסביב החתך סימנים ראשוניים של זיהום ("זיהום מוקדם"), והמטופל מציין תגובה אנפילקטית ל-Penicillin?

א. Doxycycline
ב. Tigecycline
ג. Vancomycin
ד. Linezolid

93. מה עלול להגביל את השימוש ב- Trimethoprim-Sulfamethoxazole?

א. שימוש מקביל ב- Warfarin
ב. שימוש מקביל ב- Bisoprolol
ג. Hypokalemia < 3mEq/L
ד. Hypernatremia >145 mEq/L

94. מה ההבדל העיקרי בין Randomized controlled trials (RCT) לבין Retrospective observational studies?

א. ב- RCT ניתן להימנע מ- selection bias
ב. במחקר רטרוספקטיבי ניתן לכלול יותר משתנים מאשר ב- RCT
ג. ב- RCT ערך ה- P-value נמוך יותר מאשר במחקר רטרוספקטיבי
ד. מחקר רטרוספקטיבי מוכיח causality

95. באיזו מחלה, שגרמה לאי ספיקת כליות חדה, יכול Eculizumab לשמש טיפול יעיל?

א. Thrombotic Thrombocytopenic Purpura
ב. Systemic Lupus Erythematosus stage V
ג. Polyarteritis Nodosa
ד. C3 Glomerulonephritis

96. איזו מחלה עלולה לגרום ל- Membranous glomerulonephritis?

א. Syphilis
ב. Schistosomiasis
ג. Streptococcal endocarditis
ד. Epstein-Barr virus infection

97. בן 20, פונה למיון בשל חום, צמרמורות כאבי פרקים ופריחה המודגמת **בתמונה 11**.
בבדיקה מלווה ארתריטיס נודדת וטנוסינוביטיס מה נכון?

א. רוב הסיכויים שתרבית דם תהיה חיובית
ב. תרבית מנוזל סינוביאלי תמיד שלילית
ג. רוב הסיכויים שתרבית מהנגעים העוריים תהיה חיובית
ד. רוב הסיכויים שתרבית מהאף תהיה חיובית

98. בת 52 עם היפרפאראתירואידיזם ראשוני וסידן מקסימלי של 12 מ"ג/ד"ל (אלבומין תקין). בעבר אובחן שבר בחוליה L4, ולפני שנתיים אבן חוסמת בכליה השמאלית.
איזה מאפיין <u>לא</u> מהווה חלק מההתוויות לניתוח בחולה זו?

א. הגיל
ב. שבר בחוליה
ג. מחלת האבנים בדרכי השתן
ד. ערכי הסידן

99. בת 23, מתלוננת על כאבים בבטן מרכזית כ- 3-2 פעמים בשבוע מזה כשנה. הכאבים מוקלים לאחר יציאות. מתלוננת גם על תקופות של עצירות ותקופות של שלשול. מה מתאים לאבחנה של Irritable Bowel Syndrome?

א. ירידה במשקל של כ- 10 ק"ג
ב. כאבי בטן מוחמרים בשעות הלילה
ג. שלשול מוחמר בשעות הלילה
ד. החמרה בתלונות סביב וסת

100. בת 35, פונה לחדר המיון בשל דמם בחניכיים. משטח הדם **בתמונה 12**. מה מנבא פרוגנוזה טובה?

א.NPM1
ב.-Del 5 q
ג.T(15; 17)
ד.TP 53

101. איזה פתוגן צפוי במיוחד ב- Community Acquired Pneumonia בחולה COPD?

א. *Haemophilus influenzae*
ב. *Staphylococcus aureus*
ג. Oral anaerobes
ד. *Klebsiella pneumoniae*

102. בת 55 הסובלת מקוצר נשימה במאמצים מינימאליים, עוברת צנתור ימני לצורך בירור יתר ל״ד ריאתי. ידוע על יתר ל״ד לא מאוזן ומחלה מיטרלית ראומטית עם פרפור כרוני. איזו תוצאה תכוון למחלת הבסיס?

	Wedge pressure, mmHg	תנגודת ריאתית, יח׳ ווד (תקין – עד 3)
א	20	4
ב	12	4
ג	20	2.5
ד	14	2.5

103. בת 68, עברה בירור בחשד ליתר ל״ד ריאתי שחלק מתוצאותיו **בתמונה 13**. מה הטיפול במצבה בנוסף לאנטיקואגולציה?

א. Tadalafil
ב. Bosentan
ג. Riociguat
ד. Epoprostenol

104. בת 38, בהריון בטרימסטר ראשון, מגיעה לחדר המיון עם חום גבוה, כאב ראש ופריחה המוצגת **בתמונה 14**. מה הטיפול המומלץ?

א. Trimethoprim-Sulfamethoxazole
ב. Azithromycin
ג. Chloramphenicol
ד. Ciprofloxacin

105. בת 60 מתלוננת על פריחה ברגל ימין עם רגישות עזה. ברקע לימפאדמה כרונית של הרגליים. בבדיקה אודם בשוק ימין עם קו דמרקציה ברור וגבולות מעט מורמים, חום מקומי ורגישות במישוש. מהי הגישה הנכונה במטופלת זו?

א. טיפול קו ראשון הוא Cephalosporine דור שני או שלישי
ב. בזיהומים חוזרים יש לשקול טיפול מונע ב- Benzathine Penicillin
ג. Macrolides אינם מהווים תחליף טוב במקרה של רגישות ל- Penicillin
ד. מתן Clindamycin מחייב שילוב עם תכשיר אנטיביוטי נוסף במקרה זה

106. מה הסיבה והמשמעות של Advanced care planning/directives (הנחיות/הוראות מקדימות)?

א. לברר את רצון המטופל לגבי טיפול רפואי בסוף החיים במידה ואינו כשיר
ב. להגדיר את זהות מקבלי ההחלטות בקשר להסכמה לפעולות פולשניות
ג. המנגנון החוקי היחיד המאפשר הגדרת Do Not Resuscitate (DNR)
ד. המנגנון החוקי היחיד לקבלת החלטות לגבי Palliative care

107. מה נחשב כסיבוך אפשרי של מתן מנות דם מרובות (massive transfusion)?

א. היפרקלצמיה
ב. היפוקלמיה
ג. בססת מטבולית
ד. חמצת מטבולית

108. באיזה מצב יש לשקול מתן טיפול באנטיקואגולציה בחולה עם היפואלבומינמיה של 2.3 גר'/ד"ל ופרוטאינוריה של 5 ג'/יממה?

א. חלבון בנס-ג'ונס בשתן מעל 3.5 ג'
ב. נוגדנים חיוביים כנגד PLA2R
ג. רמת IgA בדם פי 3 מהנורמה
ד. קריאטנין 4.5 מ"ג/ד"ל

109. איזו תרופה יכולה לסייע בהפחתת רמות חומצה אורית בקרב חולי Gout?

א. Mineralocorticoid antagonist
ב. β-Blocker
ג. Furosemide
ד. SGLT2 inhibitor

110. למי מהבאים, עם היפרגליקמיה הנובעת מטיפול בסטרואידים, מתאימה התרופה המצוינת בטבלה?

		גלוקוז בצום	טיפול
א.	בן 70	220 mg/dL	Glybenclamide
ב.	בת 73	210 mg/dL	Insulin
ג.	בן 48	185 mg/dL	Insulin
ד.	בת 55	230 ng/dL	Metformin

111. בת 30, עם Irritable Bowel Syndrome. סובלת מכאבי בטן ושלשול, ופגיעה חמורה באיכות חייה. מה ניתן לומר לה לגבי טיפול אפשרי?

א. Loperamide צפוי להשפיע פחות עם הזמן ומצריך שימוש במינונים עולים
ב. דיאטת Low FODMAP לא צפויה להועיל במקרה זה
ג. ל- Rifaximin יעילות גם לאחר סיום הטיפול
ד. יעילות Tricyclic antidepressants קשורה באופן ישיר להשפעה על המרכיב הנפשי

112. בת 46, נמצאת בבירור המטולוגי עקב טרומבוציטוזיס של 950,000 בממ"ק. שאר הספירה תקינה. בדיקת JAK2 שלילית. מה בדיקת הבחירה בחולה?

א. CALR ו- MPL
ב. Erythropoietin
ג. ABL/BCR
ד. FLT3

113. בן 73, מתלונן על קוצר נשימה במאמצים קלים ושיעול יבש. בספירומטריה: FVC 75%, FEV1 80%, DLCO 65% (הכל בערכים מהצפוי). ספירת הדם ללא אאוזינופיליה. CT חזה **בתמונה 15**. מה הטיפול המתאים במטופל זה?

א. Pirfenidone
ב. Azathioprine + Prednisone
ג. Levofloxacin
ד. Mepolizumab

114. מה צפוי למצוא בהיצרות לא משמעותית של המסתם האאורטלי?

א. דופק קרוטידי בצורת Parvus et Tardus
ב. דופק מרכזי בצורת Bisferiens
ג. דופק אפיקלי חזק ומוסט שמאלה
ד. איוושה סיסטולית מאוחרת בדרגה 3/6

115. בן 55, שעה לאחר הכנסת סטנט ל- LAD, מתלונן על קוצר נשימה ובבדיקה: לחץ דם 80/40 ממ"כ, דופק 100 סדיר וגודש בווריד הצוואר. תרשים האק"ג **בתמונה 16**. מה הבדיקה האבחנתית ביותר?

א. צנתור כלילי חוזר
ב. אקוקרדיוגרפיה
ג. CTA של הריאות
ד. החדרת Swan-Ganz

116. בן 40, שב מטיול בדרום מזרח אסיה ומדווח על חום, צמרמורת ושלשול דמי. מה הטיפול הפומי המתאים במקרה זה?

א. Trimethoprim-Sulfamethoxazole
ב. Roxithromycin
ג. Ciprofloxacin
ד. Rifaximin

117. בת 70, סוכרתית ומושתלת כליה, מאשפזת עקב דלקת ריאות. תוך כדי טיפול אנטיביוטי משלשלת באופן משמעותי. הקריאטינין עולה ל- 2 מ״ג/ד״ל (מערך תקין בבסיס), והלויקוציטים בדם 20,000 בממ״ק. המטופלת מציינת זיהום ב- *C. difficile* לפני 4 חודשים. מה הטיפול המתאים כעת?

א. Fidaxomycin
ב. Metronidazole
ג. השתלת צואה במתן פומי
ד. השתלת צואה באמצעות חוקן

118. בת 74, מאושפזת בשל קוצר נשימה, שלא הגיב לטיפול במסגרת הוספיס בית. ידוע על סרטן שחלה גרורתי, וכעת לאחר הפסקת טיפול אונקולוגי, קכקטית ומרותקת למיטה. מה צריכה להיות ההתייחסות לקוצר הנשימה?

א. הטיפול המיטבי קשור למדדי אחוזי החמצן והפחמן הדו חמצני בדם
ב. יש לשקול ביצוע CTA לבירור אפשרות של תסחיף ריאתי
ג. יש להימנע מטיפול בבנזודיאזפינים מחשש לשקיעה הכרתית ודלירים
ד. יש לטפל באופיואידים לשיפור התסמינים דרך מנגנונים מרכזיים והיקפיים

119. בת 50, ביצעה ביופסיה לבירור של CKD. בביופסיה נמצא Chronic interstitial nephritis עם משקעי Calcium oxalate. מה הסיבה לכך בסבירות הגבוהה ביותר?

א. טיפול כרוני ב- Lithium
ב. Light chain deposition disease
ג. Familial hypercalciuric hypercalcemia
ד. מחלת Crohn's לא מאובחנת

120. מה מהבאים הוא סיבוך אפשרי של רמת זרחן בדם 0.6 מ"ג/ד"ל?

א. Prolonged QT
ב. Rhabdomyolysis
ג. Hypocalcemia
ד. Metabolic alkalosis

121. בן 32 סובל מהתקפי חום, כאבי בטן הנמשכים 72-48 שעות מגיל 10. בבדיקה גנטית נמצא הומוזיגוט ל- M694V. לאיזו מחלה נמצא המטופל בסיכון מוגבר?

א. Ankylosing Spondylitis
ב. Systemic Lupus Erythematosus
ג. Dermatomyositis
ד. Systemic Sclerosis

122. בן 55, מעשן עם יתר ל"ד. מגיע לחדר המיון עם כאבים עזים בחזה קורנים לגב. בבדיקה נמצא באי-שקט ניכר, ל"ד 185/130 ממ"כ, דופק 95, סטורציה 95% באוויר חדר. תרשים אק"ג וצילום החזה **בתמונה 17**. מה הטיפול הראשוני?

א. IV Isosorbide dinitrate
ב. IV Phentolamine
ג. IV Labetalol
ד. IV Hydralazine

123. בן 28, ירד במשקל כ- 40 ק״ג בשנה האחרונה לאחר ניתוח בריאטרי. מאושפז בשל חולשה ניכרת וקושי לעמוד על רגליו. בבדיקה: כוח גס שמור בידיים, אך ברגליים החזרים ירודים וירידה בכוח הגס 3/5. באיזה ויטמין יש לטפל בו?

א. Niacin
ב. Vitamin A
ג. Vitamin B1
ד. Vitamin B12

124. בת 45, מאושפזת עקב צהבת והפרעה באנזימי כבד. בילירובין 18 מ״ג/ד״ל, בילירובין ישיר 13 מ״ג/ד״ל, AST 190 יח׳ ו- ALT 180 יחי׳, אלבומין 2.9 גר׳/ד״ל, INR 2.1. כיצד נטפל בהפרעת הקרישה?

א. FFP
ב. Vitamin K
ג. Cryoprecipitate
ד. PCC

125. בן 40, ברקע עישון של כ -5 שנות חפיסה. לאיזו מחלה מתאימה הספירומטריה **שבתמונה 18**?

א. Bronchial asthma
ב. Chronic Obstructive Pulmonary Disease
ג. Idiopathic pulmonary fibrosis
ד. Pulmonary hypertension

126. בת 55, ללא רקע ידוע, התקבלה בשל מחנק ודקירות בחזה בזמן טיפול שיניים. באק"ג תבנית של STEMI. בצנתור הודגמה מחלה כלילית לא משמעותית. מה מאפיין את מצבה?

א. שיעור הסיבוכים והתמותה בתוך בית חולים זהה לזה של אוטם חד בשריר הלב
ב. סיבוך אפשרי הוא הפרעת קצב חדרית משנית להתקצרות מקטע QT
ג. קיימת נטייה להישנות ב- 50% מהמטופלים
ד. הממצאים באק"ג מסייעים באבחנה בין מצבה לאוטם חד

127. בן 40, מתקבל עקב חום,פריחה מקולו-פפולרית, כאב ראש, בלבול ופרכוס פוקאלי. מה צריך להיכלל בטיפול האמפירי?

א. Ertapenem
ב. Vancomycin
ג. Acyclovir
ד. Ganciclovir

128. בת 35, בהריון שבוע 8, כשלפני 3 חודשים אובחן יל"ד והחלה טיפול ב- Amlodipine. ל"ד ממוצע בניטור של 24 שעות 158/85 ממ"כ. במעבדה: קריאטנין 0.8 מ"ג/ד"ל. ב- US: הכליות בגודל תקין וקיימת היצרות של כ- 60% בעורק כליה ימני. איזה בירור נוסף ראוי לבצע?

א. מיפוי כליות
ב. דגימת רנין בצנתור ורידי הכליות
ג. אקוקרדיוגרפיה
ד. דופלקס קרוטידים

129. מה גורם הסיכון המשמעותי ל- Vascular calcifications ועלייה בתמותה קרדיו-וסקולרית בחולים עם End Stage Kidney Disease?

א. Low bone turnover
ב. Hypocalcemia
ג. Hyperparathyroidism
ד. Hypophosphatemia

130. בת 35 עם אסתמה קשה מזה שנתיים מתאשפזת במחלקה פנימית בהתקף קוצר נשימה. בקבלתה מלינה מלבד קוצר הנשימה גם על חולשת רגל ימין וירידה בתחושה ברגל שמאל, בבדיקות הדם: אאוזינופיליה בולטת, אנמיה קלה, טרופונין פי 10 מהנורמה ו- anti-myeloperoxidase חיובי. בצילום חזה תסנינים ריאתיים ובאקו לב תפקוד ירוד גלובלי של חדר שמאל עם EF 30%. מה הטיפול המומלץ?

א. סטרואידים בלבד
ב. סטרואידים ו- Cyclophosphamide
ג. סטרואידים ו- Mepolizumab
ד. סטרואידים ו- Omalizumab

131. בן 65, שברקע יל"ד, סוכרת ומחלת לב איסכמית, מתאשפז בשל הקאות דמיות. הטיפול ב- Aspirin מופסק ובגסטרוסקופיה יום לאחר אשפוזו, מודגם כיב קיבה עם כלי דם מדמם, ולכן מבוצע טיפול אנדוסקופי. מה נכון לגבי טיפול אנטיאגרגנטי המשכי?

א. יש לחדש את הטיפול ב- Aspirin בהקדם האפשרי (תוך 1-7 ימים)
ב. יש לחדש את טיפול ב- Aspirin לאחר אנדוסקופיה חוזרת לאחר 8 שבועות
ג. אין לחדש את הטיפול ב- Aspirin בשל הסיכון המוגבר לדמם חוזר
ד. יש להעביר את המטופל לטיפול ב- Clopidogrel במקום ה- Aspirin

132. בת 52, סובלת מ- CML ומטופלת מזה 4 חודשים ב- Dasatinib. מזה שבועיים תלונות של קוצר נשימה. בצילום חזה עדות לנוזל פלאורלי מימין. מה יש לעשות כעת?

א. לבצע ביופסיה פלאורלית
ב. להוריד את מינון התרופה
ג. להתחיל טיפול במשתנים
ד. להתחיל טיפול נוגד קרישה

133. איזה תרשים נשימה **בתמונה 19** מתאים לבת 35, עם Goiter?

א.
ב.
ג.
ד.

134. מה ימצא בסבירות הגבוהה ביותר בבדיקה גופנית של חולה עם תרשים האק"ג **בתמונה 20**?

א. Giant A waves
ב. Mid systolic click
ג. Mid systolic murmur
ד. Holosystolic murmur

135. בת 50, מקבלת טיפול למיאלומה נפוצה, כשידוע על אלרגיה לפניצילין. מתאשפזת עקב חום וכאב ראש. ב- LP פלאיציטוזיס, גלוקוז נמוך ובמשטח – מתגים גרם-חיוביים. מה הטיפול המתאים?

א. Meropenem
ב. Trimethoprim-Sulfamethoxazole
ג. Ceftriaxone
ד. Ceftazidime

136. מה נכון בהקשר של אבחנת אנצפליטיס ויראלית?

א. IgM חיובי לקדחת הנילוס המערבי בדם וב- CSF שוה ערך מבחינה אבחנתית
ב. MRI ידגים נגעים טמפורליים בפחות מ- 50% ב- HSV1-encephalitis
ג. לתרבית וירוסים שלילית, חשיבות בשלילת אבחנה של אנצפליטיס עקב HSV1
ד. PCR ל- HSV1 עלול להיות שלילי ב- 3 ימים ראשונים של האנצפליטיס

137. בן 65 עם End Stage Kidney Disease, אושפז עקב כיב קיבה מדמם ונזקק ל- 3 מנות דם ודיאליזה. באיזה מצב יש להתחיל טיפול ב- Erythropoiesis stimulation agents?

א. TIBC מתחת ל- 15% לפני מנות הדם
ב. עליה בהמוגלובין מ- 8.5 ל- 13 אחרי מנות דם
ג. רמת פיברינוגן מעל 200 אחרי מנות דם
ד. רמת פריטין 250 נ"ג/מ"ל לפני מנות הדם

138. בן 50, מאושפז לבירור חום, כאבי בטן, ירידה במשקל וארתרלגיה בברכיים וקרסוליים מזה כחודש. בבדיקה ל"ד 160/90 ממ"כ ופריחה נודולרית בעור. במעבדה: קריאטנין 5.5 מ"ג/ד"ל, המוגלובין 7.5 ג/ד"ל (נורמוציטי). בשתן 5-10 אריתרוציטים. ב- CT בטן חשד להיצרות של עורק כליה ימין ואנאוריזמה 1.1 ס"מ בעורק ההפטי. מה נכון לגביו?

א. האבחנה ברורה ואין צורך בבירור או באישור נוסף
ב. ביופסיה מנגע בעור יכולה להוביל לאבחנה וודאית
ג. סרולוגיה חיובית ל- HBV מהווה קריטריון ודאי לאבחנה
ד. סרולוגיה שלילית ל- Anti PR3 ו- Anti MPO כקריטריון לאבחנה

139. על פי קריטריוני SLICC לאבחנת לופוס בחולה עם ANA חיובי, איזה קריטריון בודד נוסף יספיק לאבחנה?

א. ביופסיית כליה המדגימה לופוס נפריטיס
ב. פסיכוזה
ג. אנמיה המוליטית אוטואימונית
ד. נוגדן כנגד dsDNA

140. בן 75, ללא מחלות רקע. מתאשפז בגלל דמם רקטלי שהחל ביום פנייתו. בבדיקה: חיוור, ל"ד 80/40 ממ"כ דופק 110 ,לדקה סטורציה 97% באויר חדר, בטן רכה ללא רגישות במישוש, בבדיקה רקטלית דם טרי. במעבדה: המוגלובין 7 גר'/ד"ל (לפני חודש המוגלובין 12 גר'/ד"ל). החולה מטופל בנוזלים ומנת דם, ולחץ הדם עולה ל- 110/70 ממ"כ. איזו בדיקה יש לבצע כעת?

א. קולונוסקופיה
ב. גסטרוסקופיה
ג. CT angio של הבטן
ד. מיפוי כדוריות אדומות

141. בת 62, מופנית לבירור אנמיה נורמוציטית, המוגלובין 9.5 גר'/ד"ל, כששאר הספירה תקינה ומדדי ברזל תקינים. בדיקות הכימיה וחלבוני הדם תקינות. אלקטרופורזיס של חלבוני הדם ללא מקטע מונוקלונלי. מח עצם **בתמונה 21**. מה נכון לגבי הטיפול האפשרי בחולה?

א. טיפול ב- Daratumumab יכול לרפא את מחלתה
ב. אחוז התגובה ל- Lenalidomide ו- Bortezomib קרוב ל- 100%
ג. Melphalan מקובל כקו ראשון במועמדים להשתלה
ד. השתלת מח עצם אלוגנית היא צעד מקובל בטיפול בחולה זו

142. בן 45, מובא לחדר המיון מעורפל הכרה, נראה מוזנח ומכוסה בקיא. בבדיקה: ל״ד 90/60 ממ״כ, דופק 120 לדקה, חום 39^0C, סטורציה 94% באוויר חדר, חרחורים מעל חצי ריאה ימנית. מה הפרעת החומצה-בסיס על פי בדיקות המעבדה?

pH	7.25		Na	148 mEq/L
HCO_3	18		K	2.9 mEq/L
pCO_2	53		Cl	95 mEq/L
Lactate	תקין		Albumin	3.2 gr/dL

א. metabolic acidosis
ב. metabolic alkalosis+high AG metabolic acidosis+respiratory acidosis
ג. high AG metabolic acidosis+normal AG metabolic acidosis
ד. respiratory acidosis+metabolic alkalosis

143. מה יכול להימצא בתרשים האק״ג, שמאפיין את הממצא האקוקרדיוגרפי **בתמונה 22**?

א. Electrical alternans
ב. גלי S עמוקים ב- V1-4
ג. סימני LVH
ד. עלית מקטעי ST בקיר תחתון

144. בן, 60 עם סרטן לבלב מפושט לאחר ניתוחים ותוך כדי טיפול כמותרפי ומטופל ב-TPN דרך צנתר היקמן, מתקבל עקב חום, צמרמורת ונויטרופניה שאינם חולפים לאחר שבוע של טיפול אנטיביוטי. בבדיקתו ממצאים בעור המודגמים **בתמונה 23**. מה הצעד האבחנתי הבא?

א. בדיקת עיניים
ב. רמת RF
ג. רמת קריוגלובולינים
ד. US כבד

145. מה השלב הראשון בבירור פוליאוריה?

א. בדיקת אוסמולליות בשתן
ב. ביצוע מבחן צמא
ג. בדיקה לרמת ADH בדם
ד. בדיקה לרמת סידן בדם

146. בן 25 ממוצא יהודי-עירקי, סובל כבר כ- 10 שנים מאפטות בפה ובגניטליה, ארועי אובאיטיס, ארתריטיס ופריחה דמויית אקנה. כעת מתאשפז עקב DVT ברגל ימין. איזו בדיקה חשוב לבצע אם מתעורר צורך במתן נוגדי קרישה?

א. CRP בדם
ב. מבחן pathergy
ג. שיקוף ושט קיבה
ד. CT angio חזה

147. בת 63, עם מחלת לב איסכמית, כשלפני חודשיים אירוע של ACS והחדרת תומכן. מטופלת ב- Aspirin ו- Ticagrelor. מתאשפזת בשל כאבים ברום הבטן, תחושת שובע מוקדם, וירידה במשקל בחודשים האחרונים, מתוכננת לביצוע גסטרוסקופיה. מה הגישה לגבי הטיפול באנטיאגרגנטים?

א. להמשיך את ה- Aspirin ולהפסיק את ה- Ticagrelor 5 ימים לפני הפעולה
ב. להמשיך את ה- Ticagrelor ולהפסיק את ה- Aspirin 5 ימים לפני הפעולה
ג. להמשיך את הטיפול ב- Aspirin וב- Ticagrelor
ד. להפסיק את ה- Aspirin וה- Ticagrelor 5 ימים לפני הפעולה

148. בן 60, מתקבל לאשפוז עם סינקופה ובאק"ג Complete AV block. מה מהווה שיקול בעד השתלת קוצב מסוג VVI לעומת DDD?

א. CRBBB
ב. פרפור עליות כרוני
ג. קצב הלב סינוס
ד. CLBBB

149. באיזה מצב חובה להפסיק תרופה אנטי-שחפתית?

	תופעה של:	תרופה
א.	ארתרלגיה ועליה בחומצה אורית בד	Pyrazinamide
ב.	עלית AST פי 2 מהנורמה	Isoniazid
ג.	תרומבוציטופניה אוטואימונית	Rifampin
ד.	הארכת מקטע QTc	Levofloxacin

150. מה גורם להיפוקלצמיה בנוכחות PTH נמוך?

א. טיפול בביספוספונטים
ב. חסר ויטמין D
ג. היפומגנזמיה
ד. טיפול ב- Phenytoin

בהצלחה